INFORME FINAL DE CONSULTORÍA

Evaluación integral del CAIMI

Análisis de valor público y definición del modelo operativo del Centro de Atención Integral Materno Infantil

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Neiva, Huila · 27 de octubre de 2026

Carlos Alberto Sandoval Zambrano

Economista · MBA · Especialista en Finanzas · Big Data & BI
Actuarial Candidate (SOA)

Pacientes	Actividades	Registros biomédicos	Glosas
97.583	730.301	194	812

Contrato de consultoría No. 0481 de 2026 · Versión final

Ficha técnica y control documental

Campo	Contenido
Entidad beneficiaria	E.S.E. Carmen Emilia Ospina
Centro de análisis	Centro de Atención Integral Materno Infantil - CAIMI
Objeto	Evaluación integral en salud, análisis de valor público y definición del modelo operativo del CAIMI
Contrato	Consultoría No. 0481 de 2026 · Plazo: dos meses · Valor: $15.000.000
Periodo analizado	Producción y pacientes: noviembre de 2023 a junio de 2026; costos y finanzas: hasta junio de 2026; certificación biomédica: 23 de octubre de 2026
Entregables asociados	Informe y presentación ejecutiva en PDF, anexos Excel, matriz de trazabilidad y aplicativo web con sus descargas
Versión	Versión 3.0 · Actualización del 27 de octubre de 2026

ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

Este informe consolida la evidencia institucional disponible y la transforma en una lectura técnica para la toma de decisiones. Las cifras específicas del CAIMI deben interpretarse según su nivel de conciliación entre producción, costos, facturación, recaudo, cartera y glosas. Los cortes parciales de 2023 y 2026 se presentan como tales y no se comparan como años completos.

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	23 de julio de 2026	Versión inicial conservada como antecedente	Carlos Alberto Sandoval Zambrano
3.0	27 de octubre de 2026	Certificación biomédica, conciliación de fuentes y sincronización integral de entregables	Carlos Alberto Sandoval Zambrano

Presentación

Doctora
Adriana Marcela Losada Cañas
Gerente
E.S.E. Carmen Emilia Ospina
Neiva, Huila

Presento la actualización integral del informe final del Contrato de Consultoría No. 0481 de 2026. Integra la certificación biomédica del 23 de octubre de 2026 y sus reportes de servicio, mantiene la evaluación asistencial, operativa, territorial y financiera, y armoniza el informe, la presentación, los anexos y el aplicativo.

La actualización documenta el alcance real de los soportes biomédicos y corrige las diferencias entre productos. Los cortes financieros corresponden a junio de 2026. El inventario se concilia por registro, sin equiparar ubicación, funcionamiento, calibración y disponibilidad asistencial.

Se conserva la tercerización condicionada como alternativa estratégica que requiere estructuración y decisión institucional. La comparación con pesos uniformes explícitos arroja 3,89 para continuidad optimizada y 3,86 para tercerización; por tanto, no demuestra superioridad de esta última. La certificación complementa el expediente técnico y no sustituye el recibo a satisfacción ni la liquidación contractual.

Atentamente,

Carlos Alberto Sandoval Zambrano
Economista
Consultor contrato 0481 del 2026

Contenido

Sección	Contenido	Página
Parte I	Mandato, metodología y evidencia	7
Parte II	Desempeño asistencial y valor público	12
Parte III	Capacidad operativa y gobierno institucional	21
Parte IV	Análisis financiero, costos e ingresos	26
Parte V	Escenarios y recomendación estratégica	33
Parte VI	Implementación, seguimiento y cierre	37
Anexos	Matrices y soportes ampliados	41

Consulta específica: nota aclaratoria biomédica, página 24; conciliación individual de los 15 casos, página 48. La numeración corresponde a las páginas físicas del PDF.

Mapa del documento

Decisión ejecutiva

Resumen de hallazgos, recomendación y condiciones mínimas para adoptar el modelo.

Evidencia y método

Trazabilidad contractual, fuentes, calidad de datos, marco conceptual y normativo.

Desempeño asistencial

Demanda, producción, perfil demográfico, episodios y lectura técnico-científica.

Capacidad operativa

Procesos, equipos biomédicos, talento humano y gobierno de datos.

Sostenibilidad

Estados financieros, costos, facturación, RIPS, glosas y recaudo.

Implementación

Escenarios, riesgos, indicadores y hoja de ruta institucional.

Resumen ejecutivo

Pacientes	Actividades	Inventario	Glosas
97.583	**730.301**	**194**	**812**
suma por periodos	registros de producción	registros fuente	registros analizados

El CAIMI conserva una función asistencial y territorial relevante. La actualización biomédica concilia 194 registros y los 15 casos inicialmente no ubicados: 12 coincidencias por clave, dos asociaciones descriptivas y un caso sin reporte individual. La decisión operativa debe apoyarse en evidencia conciliada, capacidad de supervisión y continuidad de la atención.

DECISIÓN SUJETA A VALIDACIÓN

Mantener la estructuración de la tercerización condicionada como alternativa estratégica previa, con control público de información, activos y supervisión. Con pesos uniformes del 12,5%, continuidad obtiene 3,89 y tercerización 3,86; el modelo no acredita superioridad de tercerización. La elección exige validar ponderaciones, costos, riesgos y capacidad de implementación.

Hallazgos que explican la decisión

Demanda reportada

Los 97.583 pacientes corresponden a la suma de reportes por periodo; no acreditan personas únicas entre años. El perfil de sexo y edad utiliza el universo RIPS, con denominador propio.

Concentración operativa

Medicamentos, laboratorio clínico y urgencias concentran aproximadamente el 85,6% de las actividades clasificadas. El control de estos frentes determina la eficiencia operacional.

Contexto financiero

La E.S.E. reporta un resultado de $1.103,12 millones a junio de 2026. El resultado operacional es negativo: -$1.554,52 millones. Son cifras institucionales de un corte parcial.

Costos y conciliación

El costo CAIMI de 2025 es $9.828,12 millones. En el primer semestre de 2026, facturación menos costo es -$520,09 millones; esta diferencia no equivale a caja ni utilidad neta.

Glosas prevenibles

Salud Total concentra 665 de 812 registros de glosa. El principal concepto corresponde a consultas, interconsultas y visitas médicas, lo que orienta acciones específicas de auditoría.

Capacidad biomédica

Se clasifican los 194 registros con reglas explícitas. La certificación aporta 14 reportes para 15 casos iniciales: 12 enlaces por placa o serie, dos descriptivos y placa 8631 sin reporte individual.

Comparación ejecutiva de escenarios

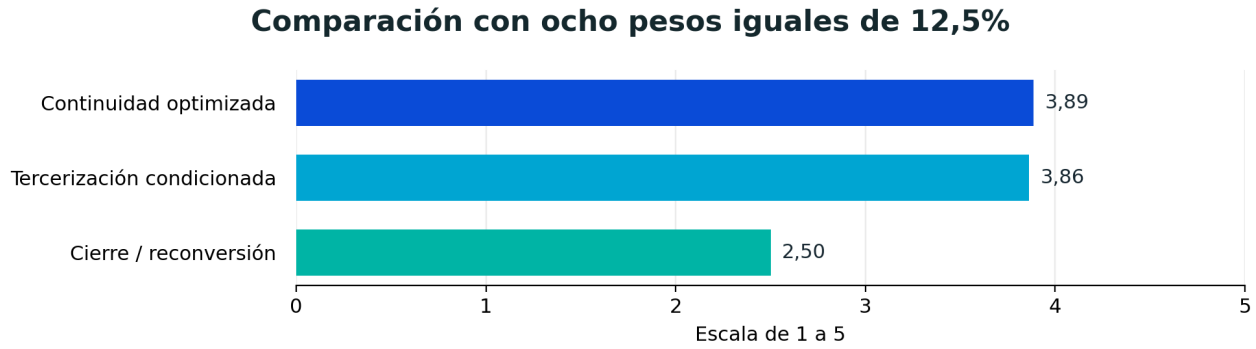


Figura 1. Puntaje global por escenario

Fuente: calificaciones originales del modelo; recálculo con ocho pesos iguales de 12,5%. Supuesto técnico explícito, no aprobación institucional. Escala de 1 a 5.

Escenario	Puntaje / 5	Lectura ejecutiva
Continuidad optimizada	3,89	Mayor puntaje con pesos uniformes; ventaja mínima
Tercerización condicionada	3,86	Alternativa estratégica previa; exige salvaguardas
Cierre / reconversión	2,50	Cierre simple no recomendado

CONDICIÓN DE VALIDEZ

Ponderación uniforme de 12,5% por criterio como supuesto técnico explícito, ante ausencia de pesos documentados. La diferencia exacta es 0,025 puntos sobre 5. Las calificaciones originales se conservan; ni los pesos ni la selección de alternativa constituyen aprobación institucional.

Mandato, metodología y evidencia

Cómo se construyó la evaluación y qué nivel de confianza soporta la decisión.

INFORME FINAL · CONSULTORÍA CAIMI

1. Alcance contractual y preguntas de decisión

El contrato exige una evaluación integral técnico-sanitaria, operativa, financiera, territorial y de valor público, así como la formulación y comparación de alternativas de modelo operativo. La consultoría se organizó para responder si el CAIMI debe continuar bajo operación directa optimizada, operar mediante un tercero sujeto a condiciones o reconvertirse/cerrar servicios, siempre que se preserve el acceso, la continuidad, la calidad y la sostenibilidad institucional.

Preguntas evaluativas

- ¿El CAIMI mejora el acceso efectivo y oportuno a servicios materno-infantiles y de primer nivel?
- ¿Su producción y utilización justifican la estructura de recursos y costos reportada?
- ¿Qué brechas pueden corregirse mediante optimización operativa, gobierno de datos y control de ingresos?
- ¿Qué alternativa maximiza el valor público sanitario sin deteriorar sostenibilidad, calidad ni continuidad?
- ¿Qué condiciones y riesgos deben incorporarse antes de adoptar la decisión?

Matriz de trazabilidad del alcance contractual

No.	Actividad contractual	Evidencia en el paquete final	Estado
1	Reunión de inicio y validación de alcance	Plan de trabajo, fuentes y gobernanza	Verificación documental de supervisión
2	Plan de trabajo y cronograma	Metodología, fases y productos	Verificación documental de supervisión
3	Revisión de información institucional	Matriz de fuentes y control de calidad	Producto incorporado; sujeto a revisión
4	Diagnóstico integral del CAIMI	Partes II, III y IV	Producto incorporado; sujeto a revisión
5	Análisis de capacidad, oferta, demanda, producción, costos y facturación	Tablas, gráficos y anexos	Producto incorporado; sujeto a revisión
6	Identificación de brechas, riesgos y oportunidades	Matriz de riesgos y hallazgos	Producto incorporado; sujeto a revisión
7	Análisis de valor público	Capítulo de valor sanitario, social y territorial	Producto incorporado; sujeto a revisión
8	Formulación y comparación de escenarios	Modelo multicriterio y sensibilidad	Producto incorporado; sujeto a revisión
9	Informe final, conclusiones y hoja de ruta	Documento consolidado	Producto incorporado; sujeto a revisión
10	Presentación ejecutiva	Presentación final en PDF	Producto incorporado; sujeto a revisión
11	Atención de observaciones de supervisión	Control de versiones y ajustes	Verificación documental de supervisión
12	Informes y soportes para pago	Paquete final de entregables	Verificación documental de supervisión

Fuente: *Contrato de consultoría No. 0481 de 2026 y propuesta técnica definitiva.*

2. Metodología de evaluación

Se aplicó una metodología mixta y trazable que combina revisión documental, análisis cuantitativo, lectura técnico-científica, evaluación operativa, análisis financiero, costeo por absorción y comparación multicriterio. La integración de estas dimensiones evita que una sola variable -por ejemplo, el costo- determine de forma aislada la decisión institucional. Para esta actualización se cotejó el inventario fila a fila con la certificación; las diferencias de identificación y los hallazgos técnicos se conservaron. No se realizó una nueva inspección física.

1. Inventario de fuentes

Identificación de bases, documentos, periodos, responsables y limitaciones.

2. Control de calidad

Validación de completitud, consistencia, oportunidad y trazabilidad.

3. Diagnóstico integral

Lectura asistencial, operativa, financiera, territorial y administrativa.

4. Modelación

Construcción de escenarios, criterios, ponderaciones y sensibilidad.

5. Recomendación

Síntesis de evidencia, salvaguardas, riesgos e implementación.

6. Trazabilidad

Correspondencia entre fuente, anexo, capítulo y decisión.

Unidades y periodos de análisis

Dimensión	Unidad de análisis	Periodo / corte
Pacientes y producción	Paciente, actividad, servicio, mes, asegurador y episodio	Noviembre de 2023 a junio de 2026; series mensuales consolidadas
Costos	Centro de costo, naturaleza y vigencia	2023, 2024, 2025 y primer semestre de 2026
Finanzas	Estados de situación financiera y resultados	31 de diciembre de 2024, 31 de diciembre de 2025 y 30 de junio de 2026
Glosas	EPS, concepto y registro	Base institucional con 812 registros
Registros biomédicos	Equipo, ubicación, estado y observación	Inventario fuente sin fecha uniforme de inspección; reportes de julio, agosto y octubre; certificación del 23/10/2026
Talento humano	Novedad, perfil y operación	Información institucional disponible

3. Calidad, consistencia y limitaciones de la información

LECTURA DE CONFIABILIDAD

La información es suficiente para identificar tendencias, brechas y prioridades y para comparar escenarios. No obstante, la decisión contractual definitiva debe precederse de una conciliación mensual específica del CAIMI que conecte centro de costo, producción, factura, radicación, glosa, recaudo y cartera.

Fuente	Nivel de confianza	Observación técnica
Pacientes	Alta	97.583 reportes acumulados por periodo; no se deduplican personas entre años. La base RIPS del aplicativo tiene otro universo.
Producción	Alta con diferencia menor	La serie mensual suma 730.301; la clasificación por servicio suma 730.281, con 20 actividades pendientes de homologación.
Costos	Alta con observaciones	Totales por vigencia trazados. Persiste diferencia de $246.421.769,62 entre componentes y total en una fila de costos; se conserva el total oficial y se solicita aclaración.
Estados financieros	Alta	Documentos certificados; su alcance es institucional y no atribuible directamente al CAIMI.
Glosas	Alta en registros	Los totales por EPS y concepto concilian en 812 registros; no equivalen al valor monetario glosado.
Registros biomédicos	Documental con salvedades	194 registros; 15 casos iniciales, 12 enlaces por clave, dos descriptivos y uno sin reporte. Serie 503352 repetida en ítems 85 y 88; no se deduplica sin soporte.
Talento humano	Media	Las categorías de novedad pueden solaparse y no deben sumarse como eventos mutuamente excluyentes.

Reglas de interpretación

- Los cortes parciales de 2023 y 2026 no se comparan como vigencias completas.
- Los estados financieros se presentan como contexto institucional, no como resultado exclusivo del CAIMI.
- Las glosas tienen frecuencias y montos multianuales; su tasa anual exige conciliación por factura.
- Los costos se interpretan por corte y centro. Se conserva el total oficial cuando existe una discrepancia entre componentes; la conciliación documental no reemplaza la validación de costos, facturación, glosas, recaudo y cartera.
- Los indicadores sanitarios sin línea base se presentan como sistema recomendado de medición, no como desempeño observado.

4. Marco conceptual y normativo

La evaluación se fundamenta en Atención Primaria en Salud, Rutas Integrales de Atención en Salud, gestión del riesgo, seguridad del paciente, redes integradas, economía de la salud, valor público y

eficiencia técnica, asignativa y productiva. En contratación, se reconoce el régimen especial de las Empresas Sociales del Estado y la aplicación de principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

Norma / fuente	Aplicación al CAIMI	Uso en la evaluación
Ley 100 de 1993, art. 195	Régimen jurídico de las E.S.E.	Marco institucional y contractual
Resolución 5185 de 2013 y modificaciones	Lineamientos del estatuto de contratación de E.S.E.	Planeación contractual
Resoluciones 1440 de 2024 y 2053 de 2025	Modificaciones de los lineamientos; art. 9 actualizado en 2025	Verificar modalidad, objeto y financiación aplicables
Resolución 3280 de 2018	Rutas de promoción y mantenimiento y materno-perinatal	Indicadores y continuidad de rutas
Decreto 441 de 2022	Acuerdos de voluntades y modalidades de pago	Nota técnica, riesgo y seguimiento
Resolución 0948 de 2026	RIPS como soporte de FEV; deroga 2275/2023, 558/2024 y 1884/2024	Validación y gobierno de datos
Circular Conjunta 007 de 2025	MinSalud y Supersalud: barreras, requisitos no normados y pagos	Radicación sin exigencias adicionales no previstas
Marco contable aplicable de la CGN	Reconocimiento, medición y presentación	Lectura de estados financieros institucionales

Fuentes: textos oficiales de MinSalud y Supersalud consultados el 27/10/2026; referencias del capítulo 34. La aplicación al acto contractual concreto exige verificar el estatuto y manual institucional vigentes; el manual de 2020 se conserva como antecedente.

II

Desempeño asistencial y valor público

Qué demanda atiende el CAIMI, cómo se usa y qué valor aporta a la red.

INFORME FINAL · CONSULTORÍA CAIMI

5. Rol territorial y articulación en red

El CAIMI funciona como un punto relevante de atención dentro de la red de primer nivel al concentrar servicios de urgencias, consulta externa, apoyo diagnóstico, medicamentos, promoción y prevención y componentes materno-infantiles. Su valor territorial se expresa en la posibilidad de atender demanda cercana, sostener continuidad y reducir desplazamientos hacia otros nodos. Por ello, cualquier cambio del modelo debe demostrar capacidad de absorción de la red y preservar la oportunidad de las rutas.

Acceso

Punto territorial que reduce barreras y congestión de otros servicios.

Continuidad

Articulación de urgencias, apoyo diagnóstico y seguimiento de rutas.

Equidad

Atención a población usuaria con exposición diferencial a barreras.

Sostenibilidad

Necesidad de controlar costos, glosas, productividad y equipos.

IMPLICACIÓN PARA UN EVENTUAL CIERRE

El cierre simple no puede analizarse como eliminación contable de costos. Debe cuantificar demanda desplazada, capacidad real de absorción, tiempos de traslado, continuidad de la atención, manejo de activos y talento humano y costos de transición.

6. Demanda atendida

La base de pacientes reporta 97.583 registros acumulados por periodo: 13.131 en noviembre-diciembre de 2023, 39.624 en 2024, 33.630 en 2025 y 11.198 en enero-junio de 2026. La suma no representa personas únicas entre años. Los cortes parciales no son comparables con vigencias completas.

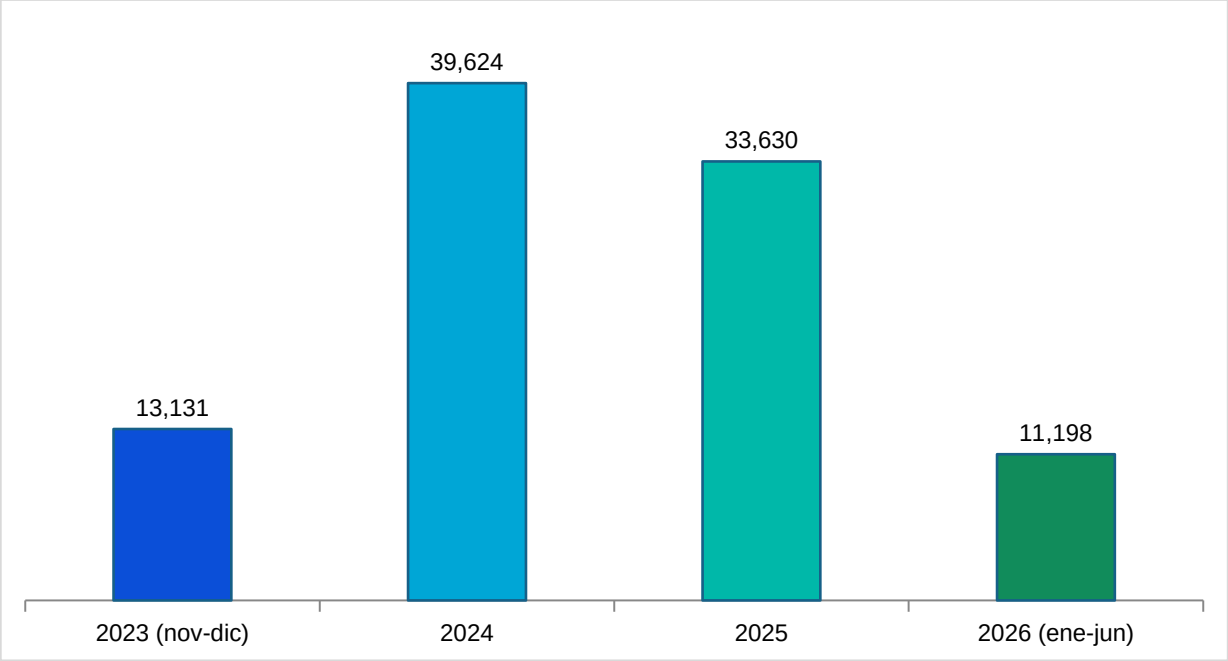


Figura 2. Pacientes reportados por periodo

Fuente: *Base institucional consolidada de pacientes. Los cortes de 2023 y 2026 son parciales.*

Periodo	Pacientes	Participación
2023 (nov-dic)	13.131	13,5%
2024	39.624	40,6%
2025	33.630	34,5%
2026 (ene-jun)	11.198	11,5%

7. Tendencia mensual de actividades

La serie mensual consolidada muestra una actividad más alta entre enero y junio y una reducción durante el segundo semestre. Dado que la matriz integra diferentes vigencias, la tendencia debe leerse como patrón agregado de operación y no como estacionalidad causal demostrada. La utilidad principal es orientar capacidad, programación y control de variaciones no explicadas.

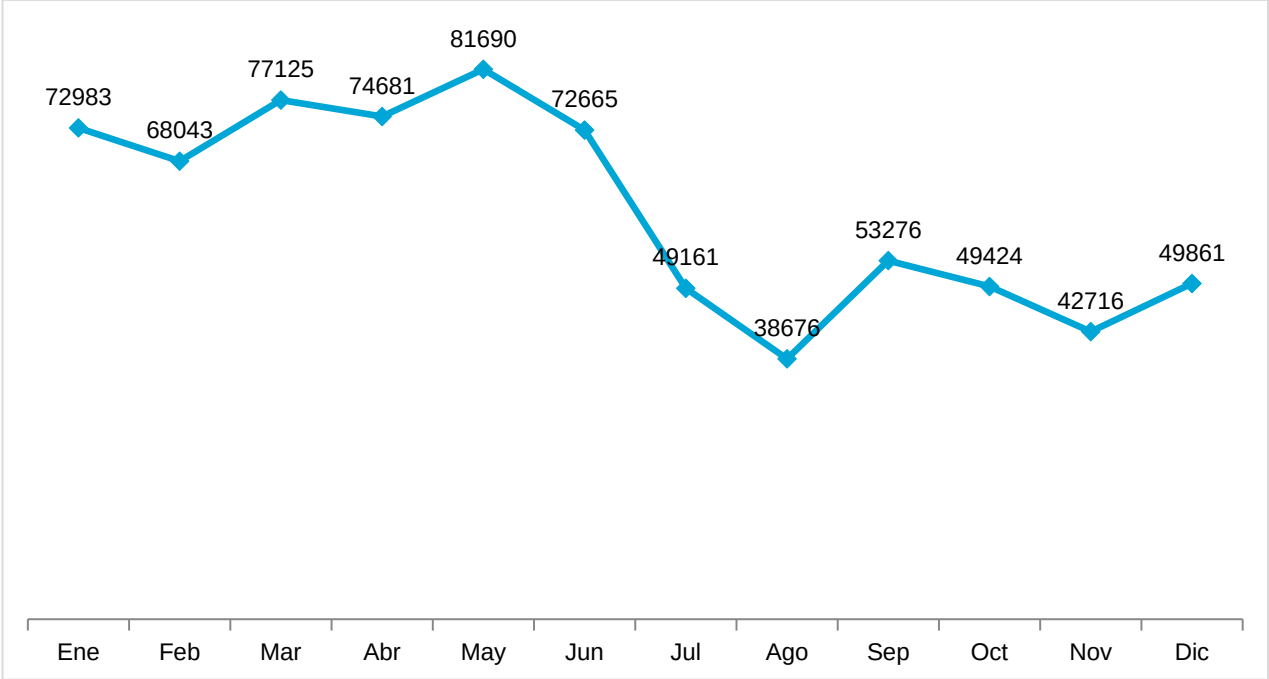


Figura 3. Tendencia mensual agregada de actividades

Fuente: *Matriz mensual institucional. Total conciliado: 730.301 actividades.*

CONTROL RECOMENDADO

Implementar una alerta mensual cuando la variación de producción supere un umbral institucional sin causa documentada. El análisis debe distinguir demanda, indisponibilidad de agendas, mantenimiento, ausentismo, fallas de registro y decisiones contractuales.

8. Composición de la producción

La operación presenta una alta concentración en medicamentos, laboratorio clínico y urgencias. Estos tres grupos representan aproximadamente el 85,6% de las actividades clasificadas y, por tanto, deben concentrar los controles de capacidad, insumos, oportunidad, soportes de facturación, productividad y mantenimiento.

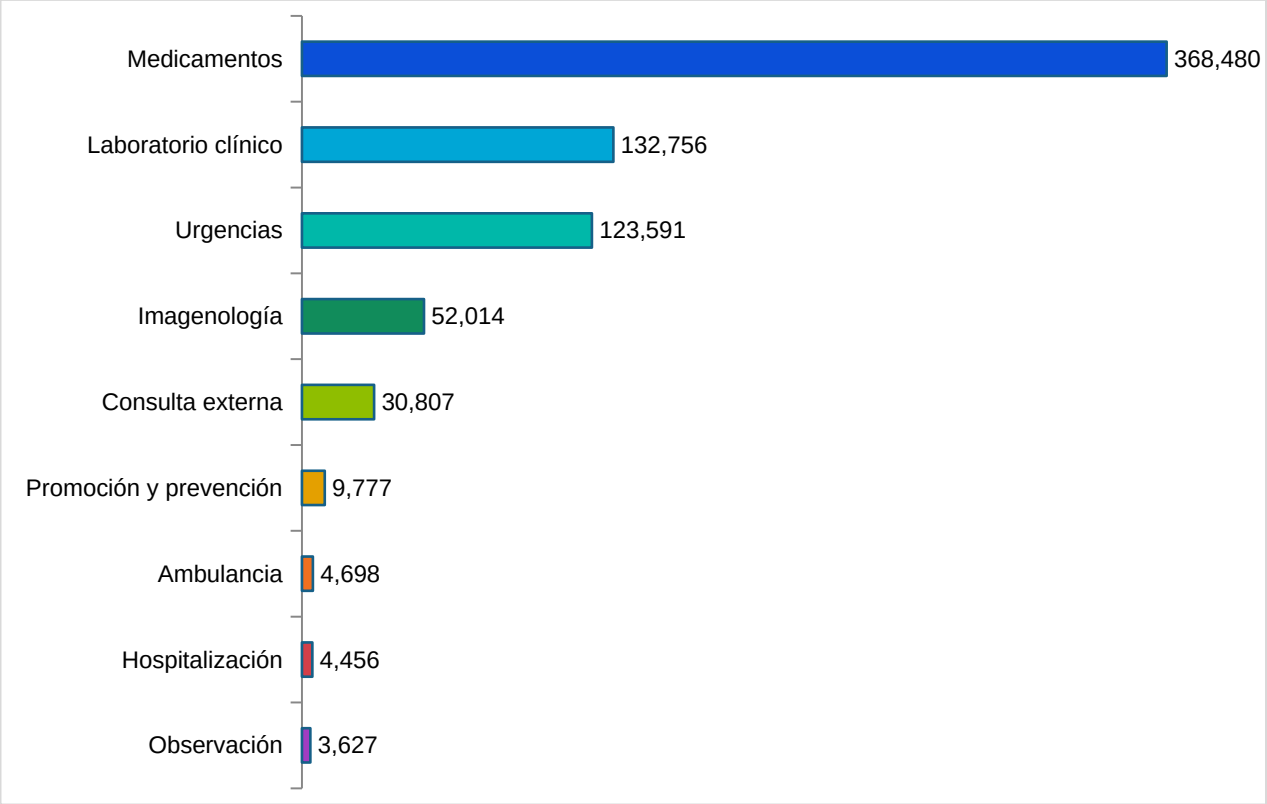


Figura 4. Actividades por grupo de atención

Fuente: *Base institucional de producción. La clasificación por servicio suma 730.281 registros; 20 requieren homologación.*

Grupo de atención	Actividades	Participación
Medicamentos	368.480	50,5%
Laboratorio clínico	132.756	18,2%
Urgencias	123.591	16,9%
Imagenología	52.014	7,1%
Consulta externa	30.807	4,2%
Promoción y prevención	9.777	1,3%
Ambulancia	4.698	0,6%
Hospitalización	4.456	0,6%
Observación	3.627	0,5%
Otros	75	0,0%

9. Perfil demográfico

El perfil de sexo y edad utiliza los 371.987 registros RIPS de diagnóstico principal o egreso, con 68.318 usuarios deduplicados en la base. Es un universo diferente de los pacientes reportados por periodo. El

sexo femenino representa el 61,67% de estos registros. Las edades de 29 a 59 años concentran el 33,75% y las de 60 años o más el 23,00%.

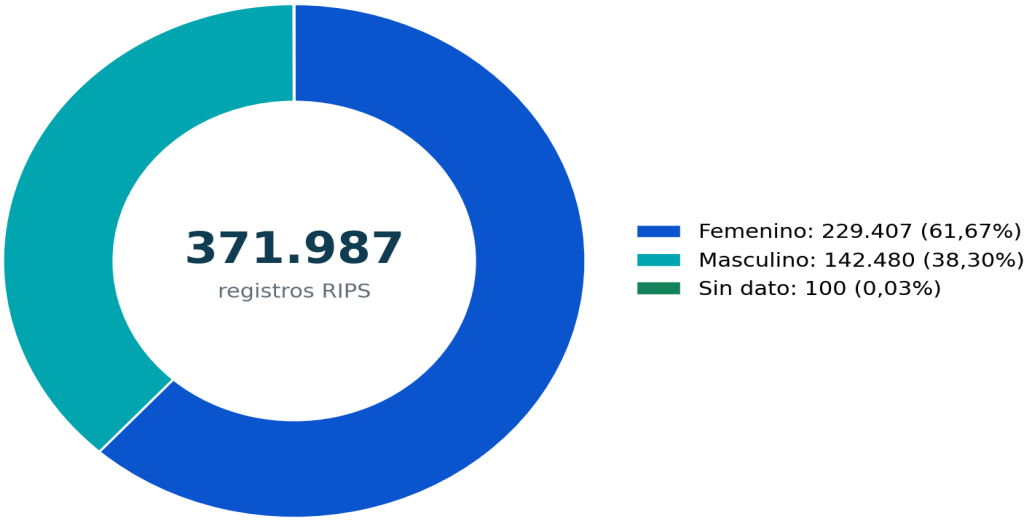


Figura 5. Registros RIPS de diagnóstico principal o egreso por sexo

Fuente: vectores RIPS del aplicativo, corte 30/06/2026. Denominador: 371.987 registros diagnósticos; femenino 61,67%, masculino 38,30% y sin dato 0,03%.

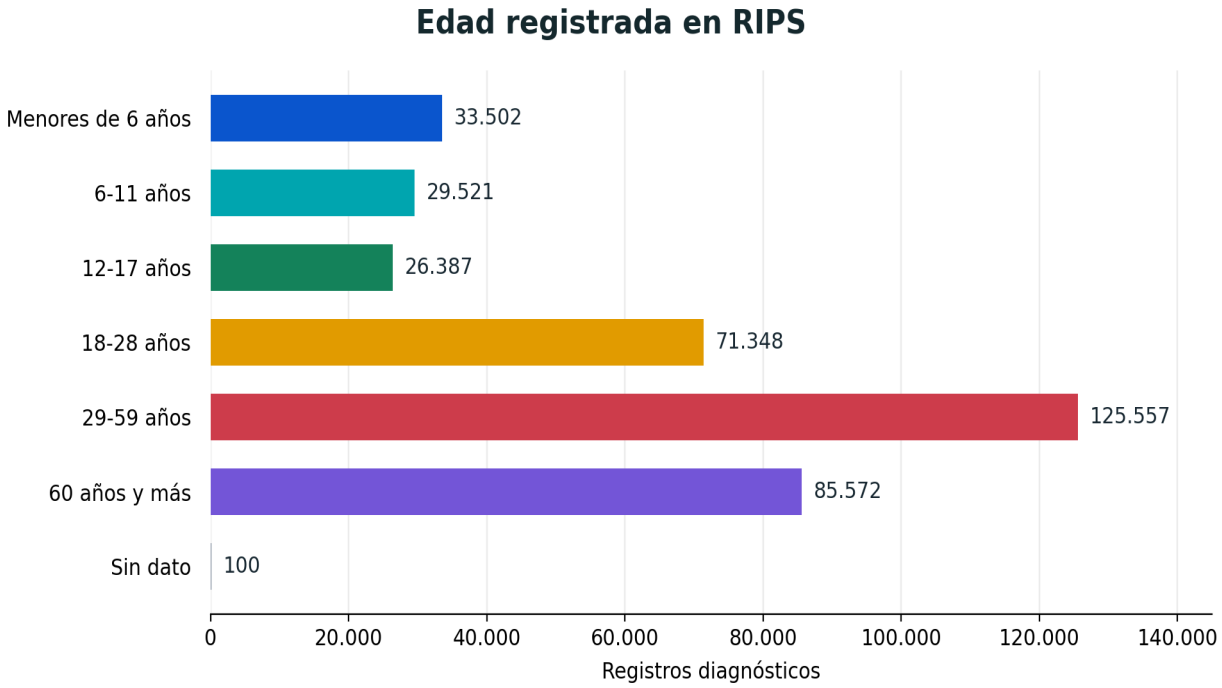


Figura 6. Registros RIPS de diagnóstico principal o egreso por edad

Fuente: mismo universo RIPS de 371.987 registros. Se agrupan <1 y 1-5 años, y 29-44 y 45-59 años. Las cifras no representan personas únicas por grupo.

Edad agrupada en RIPS	Registros	Participación
Menores de 6 años	33.502	9,01%
6-11 años	29.521	7,94%
12-17 años	26.387	7,09%
18-28 años	71.348	19,18%
29-59 años	125.557	33,75%
60 años y más	85.572	23,00%
Sin dato	100	0,03%

10. Perfil epidemiológico y categorías de diagnóstico

El conjunto RIPS del aplicativo contiene 745.006 registros de diagnóstico y 68.318 usuarios deduplicados dentro de esa base. El alcance principal o egreso suma 371.987 registros. Se utiliza este último para el ranking del capítulo. Son universos distintos de los 97.583 pacientes reportados por periodos y de las 730.301 actividades de producción.

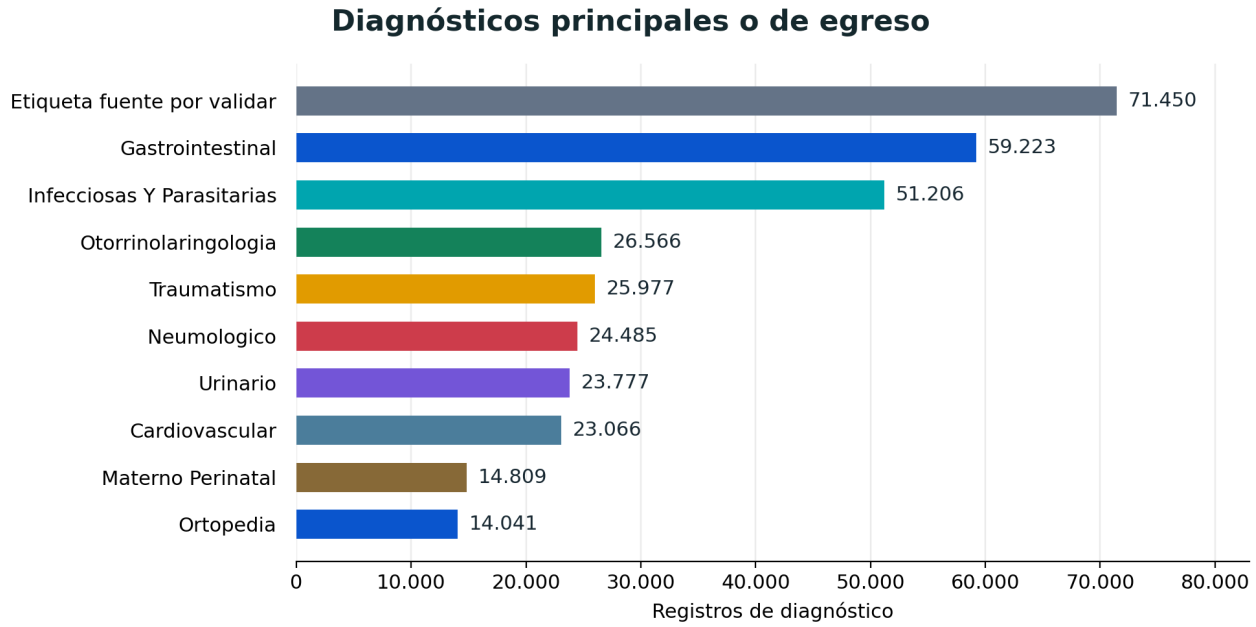


Figura 7. Condiciones de diagnóstico principal o egreso

Fuente: rips-v22-data.js del aplicativo existente, corte 30/06/2026; recálculo de vectores. Denominador: 371.987 registros. «DIAGNOSTICO NO VALIDO» conserva la etiqueta fuente y requiere revisión de clasificación; no acredita invalidez clínica de cada registro.

Categoría de episodio en la fuente	Registros principal / egreso
EXAMEN MEDICO GENERAL	48.039
INFECCIONES OTROS VIRUS	38.365

Categoría de episodio en la fuente	Registros principal / egreso
SIGNOS Y SINTOMAS GASTROINTESTINALES	21.798
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	16.249
HIPERTENSION ARTERIAL - CRISIS HIPERTENSIVAS	13.006
INFECCION URINARIA	11.987

Estas categorías agrupan registros diagnósticos y no cuentan episodios clínicos únicos. El grupo materno-perinatal reúne 14.809 registros en principal/egreso y 29.162 al incluir todos los diagnósticos. Las categorías requieren validación clínica de su diccionario.

Indicadores sanitarios recomendados

Trazador	Riesgo	Indicador	Meta sugerida
Gestantes	Ruptura de continuidad	Captación antes de semana 12 / gestantes captadas	> 90%
Urgencias	Congestión y demora	Tiempo entre triage y atención por prioridad	Meta institucional
Laboratorio	Retraso diagnóstico	Tiempo de respuesta por tipo de prueba	Meta institucional
Imagenología	Demora de apoyo	Oportunidad de lectura y reporte	Meta institucional
Equipos críticos	Falla tecnológica	Disponibilidad tecnológica	> 95%

11. Lectura técnico-científica

La decisión sobre el modelo operativo no puede fundamentarse exclusivamente en costos. El modelo seleccionado debe preservar acceso efectivo, oportunidad, continuidad, integralidad, seguridad del paciente, capacidad resolutiva y articulación con la red. En un centro con demanda relevante, una reducción de costos que deteriore continuidad o genere desplazamiento puede destruir valor público y trasladar presión hacia otros nodos.

Acceso y oportunidad

Medir tiempos, barreras, demanda desplazada y capacidad de respuesta.

Continuidad

Seguir rutas materno-infantiles, referencia, contrarreferencia y retorno.

Resolutividad

Controlar remisiones evitables y dependencia de otros nodos.

Seguridad del paciente

Priorizar mantenimiento, disponibilidad tecnológica y eventos adversos.

Pertinencia

Alinear oferta y protocolos con demanda y riesgo poblacional.

Valor en salud

Relacionar resultados, experiencia, costos y continuidad.

12. Valor público sanitario, social y territorial

El valor público del CAIMI deriva de su contribución al acceso territorial, la continuidad asistencial, la atención de alta demanda, el soporte diagnóstico y el uso de infraestructura pública. Este valor no excluye la obligación de mejorar eficiencia; exige que cualquier reorganización proteja simultáneamente resultados sanitarios y sostenibilidad institucional.

Dimensión	Aporte	Riesgo	Indicador de control
Acceso	Punto de entrada y continuidad en red	Barreras de acceso	Pacientes atendidos / demanda proyectada
Calidad	Atención con soporte clínico y diagnóstico	Eventos, retrasos y reproceso	Oportunidad y seguridad
Equidad	Atención a población usuaria del área de influencia	Desplazamiento y exclusión	Uso por territorio y asegurador
Sostenibilidad	Costos directos, indirectos y gestión de ingresos	Presión financiera	Costo por actividad y tasa de glosa
Gobernabilidad	Control público de información y activos	Pérdida de control	Cumplimiento de indicadores y reversibilidad

III

Capacidad operativa y gobierno institucional

Qué debe fortalecerse en procesos, equipos, talento humano y datos.

INFORME FINAL · CONSULTORÍA CAIMI

13. Capacidad instalada y procesos críticos

La sostenibilidad del CAIMI depende de una cadena operativa que inicia en admisión y aseguramiento, continúa en registro clínico, prestación, RIPS, facturación y radicación y termina en auditoría, glosa, recaudo y conciliación. Las fallas en un eslabón se trasladan al siguiente y pueden convertir una atención realizada en ingreso no reconocido o tardío.

Proceso	Punto de control	Riesgo	Acción prioritaria
Admisión	Identificación y aseguramiento	Rechazo o glosa por responsable de pago	Validación al ingreso
Registro clínico	Soporte completo y codificación	Inconsistencia RIPS/FEV	Checklist clínico-administrativo
Facturación	CUPS, tarifa y contrato	Diferencias de valor	Validación contractual
Radicación	Soportes y oportunidad	Devolución o glosa	Auditoría previa
Recaudo	Conciliación pago-factura	Cartera no trazada	Tablero cartera/glosa
Costos	Centro de costo e inductor	Costo no comparable	Cierre mensual de costos

PRIORIDAD OPERACIONAL

Formalizar un flujo de control de extremo a extremo con responsable, evidencia, indicador y fecha de cierre. El aplicativo y el libro de anexos deben actuar como herramientas de seguimiento, no como repositorios aislados.

14. Equipos biomédicos

El PDF institucional contiene 194 filas numeradas consecutivamente. El cotejo identifica 15 registros con observación inicial de no ubicación. La certificación del 23 de octubre de 2026 aporta 14 reportes: 12 coinciden por placa o serie, dos se asocian de manera descriptiva y el registro de la placa 8631 no cuenta con reporte individual en este anexo. Se habla de registros, pues la serie 503352 se repite en los ítems 85 y 88 y requiere conciliación.

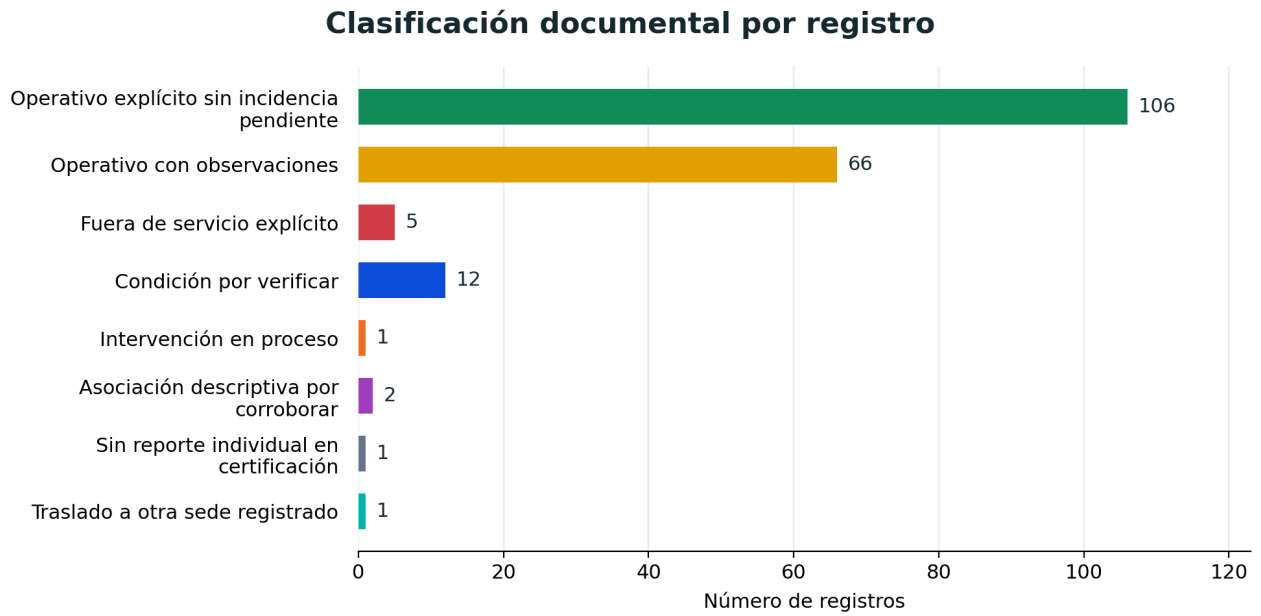


Figura 8. Clasificación documental consolidada de 194 registros

Fuentes: inventario institucional, ítems 1-194; certificación del 23/10/2026, pp. 1-16. Fechas de reportes: 09/07, 14/07, 03/08 y 08/10/2026. Categorías excluyentes; no es medición simultánea de disponibilidad.

Clasificación documental	N.º	Acción de seguimiento
Operativo explícito sin incidencia pendiente consignada	106	Mantener mantenimiento y comprobar vigencia
Operativo con observaciones	66	Cerrar hallazgos y verificar aptitud según uso
Fuera de servicio explícito	5	Aislar del uso y definir intervención o baja autorizada
Condición técnica por verificar	12	Revisar condición técnica antes de asumir operatividad
Intervención en proceso	1	Completar intervención del succionador 3259
Asociación descriptiva por corroborar	2	Corroborar identidad de ítems 181 y 182
Sin reporte individual en certificación	1	Solicitar soporte individual de placa 8631
Traslado a otra sede registrado	1	Conciliar traslado y custodia entre sedes
Total	194	Un registro pertenece a una categoría

Seguimiento técnico y documental

- Atender los cinco registros con condición explícita de fuera de servicio y la intervención en proceso; la recomendación de baja requiere decisión institucional.
- Cerrar observaciones de accesorios, corrosión, baterías o autonomía sin confundir funcionamiento básico con aptitud para cualquier uso clínico.
- Corroborar las identidades descriptivas de los ítems 181 y 182 y las diferencias de transcripción conservadas en el anexo.
- Solicitar el reporte individual de la placa 8631 y conciliar la serie 503352 repetida en los ítems 85 y 88.
- Mantener separados el estado técnico, la ubicación y la acción de gestión; renovación y baja son recomendaciones, no estados de funcionamiento.

Nota aclaratoria sobre la certificación biomédica

La certificación expedida en Neiva el 23 de octubre de 2026 por Kelly Catherine Reyes Moreno, Ingeniera Biomédica de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, se incorpora como evidencia institucional complementaria. Explica que algunos equipos no pudieron identificarse durante la visita inicial por disponibilidad, acceso a espacios y diferencias de ubicación, y aporta reportes de servicio posteriores. La ausencia de ubicación en aquella visita no acredita, por sí misma, pérdida del activo.

El cotejo se efectuó contra los 194 registros del inventario suministrado y sus 15 observaciones de no ubicación inicial. Diez reportes se enlazan por placa y dos por serie. El fonendoscopio RIESTER DUPLEX y la lámpara de lápiz WELCH ALLYN 76600 carecen de clave individual suficiente para una vinculación concluyente, por lo que se conservan como asociaciones descriptivas. Para la báscula de peso BADECOL, placa 8631 y serie 25689-334, no se identifica reporte individual entre las 16 páginas de esta certificación; se solicita su aclaración sin inferir que el equipo esté perdido.

La ubicación y la condición técnica se documentan por separado. Los soportes de las placas 2820, 3237 y 4427 informan condición fuera de servicio; el 3259 mantiene intervención en proceso; el 3404 funciona con observación de fisura del reservorio. Los reportes están fechados en julio, agosto y octubre de 2026. No corresponde afirmar que todos fueron encontrados en julio ni que la totalidad esté operativa a una misma fecha.

Esta revisión es documental. No constituye inspección física nueva, certificación metrológica, autorización de uso clínico ni ejecución de bajas. Una prueba o intento de calibración no equivale a un certificado favorable. Las diferencias de serie, modelo o rango manuscrito se conservan para validación por el área biomédica y no se corrigen en las fuentes originales.

Con la incorporación del soporte se completa esta actualización documental del componente biomédico y se entrega la matriz de seguimiento. Los hallazgos técnicos y las salvedades de identificación permanecen visibles. El recibo a satisfacción, la aprobación del cumplimiento y la liquidación del Contrato 0481 de 2026 corresponden a las instancias institucionales competentes; no se sustituyen con esta nota ni se modifica la fecha de ejecución contractual.

15. Talento humano, ausentismo y productividad

La información de ausentismo y novedades debe utilizarse como insumo de gestión operativa, no como hallazgo disciplinario. Las categorías reportadas pueden solaparse, por lo que no deben sumarse como eventos excluyentes. La principal brecha es la ausencia de un tablero que relacione agenda disponible, horas efectivas, producción, costo por perfil y continuidad del servicio.

Registros con novedad	Permisos sindicales	Compensatorios	Incapacidad / salud
26	**9**	**11**	**16**
base disponible	categoría reportada	categoría reportada	categoría reportada

Indicador	Fórmula	Uso
Productividad por perfil	Actividades / horas efectivas	Dimensionar carga y agenda
Ausentismo operacional	Días de ausencia / días programados	Gestionar continuidad

Indicador	Fórmula	Uso
Costo por agenda	Costo de talento humano / agenda efectiva	Optimizar recursos
Rendimiento por servicio	Producción / capacidad disponible	Identificar cuellos de botella

16. Gobierno de datos y sistema de información

La E.S.E. debe institucionalizar un ciclo mensual de gobierno de datos que integre producción, RIPS, facturación, radicación, glosas, recaudo, cartera y costos. El sistema debe identificar una misma atención desde el registro clínico hasta el pago, con responsables y controles de calidad en cada etapa.

Completitud

Campos obligatorios, soportes, códigos y responsables de pago.

Consistencia

Concordancia entre registro clínico, RIPS, factura y contrato.

Unicidad

Identificación de duplicados y trazabilidad de episodios.

Oportunidad

Disponibilidad de información para cierre mensual y decisión.

Trazabilidad

Seguimiento de cada transacción desde atención hasta recaudo.

Gobernabilidad

Roles, custodios, reglas, tablero y cierre de alertas.

REGLA DE CONTROL

La cifra que se utilice para gerencia, informe, Excel, presentación y aplicativo debe provenir de la misma tabla validada y conservar fecha de corte, fuente, responsable y estado de conciliación.

IV

Análisis financiero, costos e ingresos

Qué revela la información financiera y qué debe conciliarse antes de decidir.

INFORME FINAL · CONSULTORÍA CAIMI

17. Contexto financiero institucional

Al 30 de junio de 2026, la E.S.E. reporta activos por $80.960,05 millones, pasivos por $26.454,65 millones y patrimonio por $54.505,40 millones. El resultado del periodo es $1.103,12 millones, mientras el resultado operacional es -$1.554,52 millones. Estas cifras corresponden a toda la E.S.E.; no representan resultados exclusivos del CAIMI ni un cierre anual de 2026.

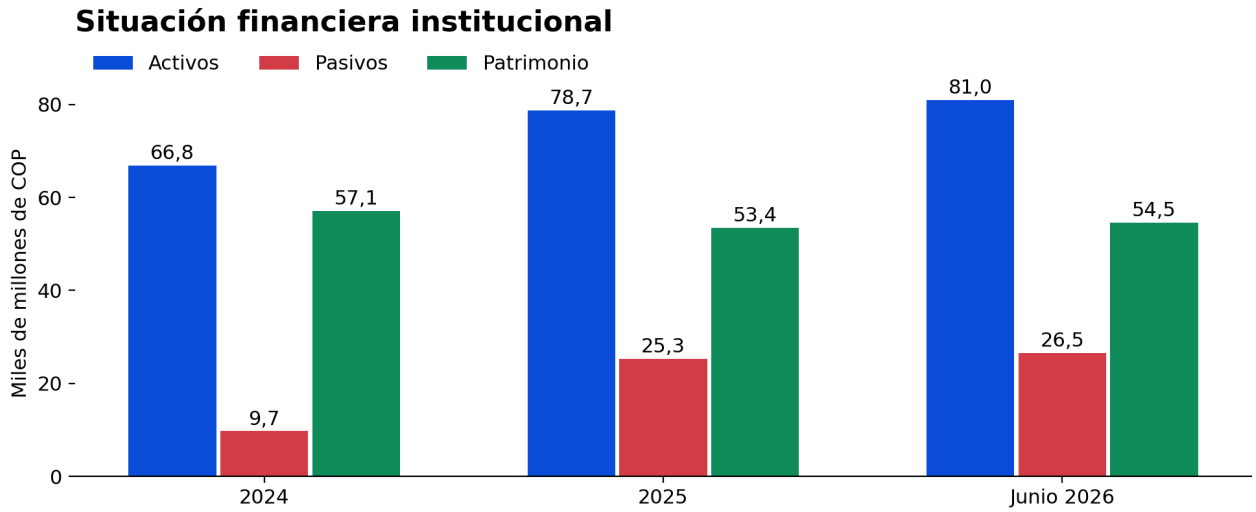


Figura 9. Activos, pasivos y patrimonio

Fuente: estados financieros certificados de la E.S.E. de 2024, 2025 y junio de 2026. Gráfico en miles de millones de COP; tablas en millones de COP. 2026 corresponde a enero-junio.

Periodo	Activos $ millones	Pasivos $ millones	Razón corriente	Pasivo / activo	Resultado $ millones
2024	66.794,29	9.703,46	1,78	14,5%	-218,58
2025	78.691,24	25.288,97	1,14	32,1%	-3.688,55
Junio 2026	80.960,05	26.454,65	1,21	32,7%	1.103,12

Indicadores derivados de los estados financieros institucionales. La razón corriente y el endeudamiento se calculan sobre saldos al cierre de cada corte.

18. Resultados y márgenes

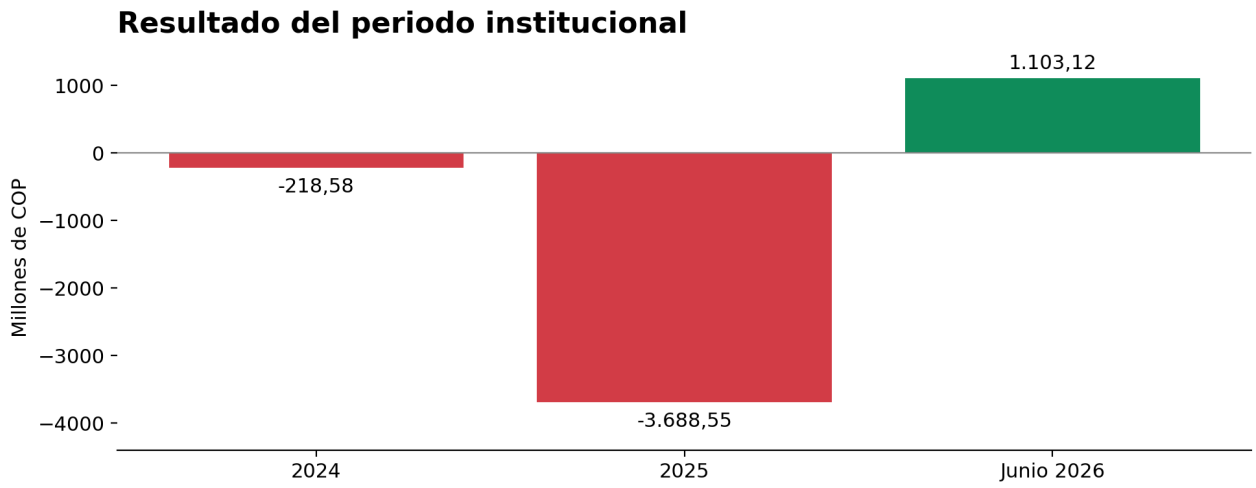


Figura 10. Resultado del periodo institucional

Fuente: estados financieros de la E.S.E. 2024, 2025 y 30/06/2026. El corte de 2026 cubre seis meses. Los resultados de periodos de distinta duración no se comparan como variación anual.

Periodo	Ingresos $ millones	Margen bruto	Resultado operacional $ millones	Margen del periodo	Capital trabajo $ millones
2024	69.178,63	27,1%	-2.313,15	-0,3%	7.588,53
2025	66.091,06	15,9%	-7.741,13	-5,6%	3.519,64
Junio 2026	33.938,31	21,9%	-1.554,52	3,3%	5.510,78

INTERPRETACIÓN

El resultado positivo del periodo a junio de 2026 coexiste con un resultado operacional negativo. El capital de trabajo de junio es $5.510,78 millones; la razón corriente es 1,21. La sostenibilidad exige examinar los componentes del resultado, costos, cartera y recaudo, sin extrapolar el semestre al año.

19. Metodología de costeo institucional

La E.S.E. utiliza costeo por absorción. Esta metodología incorpora costos directos e indirectos, fijos y variables, los acumula en centros de costo y redistribuye los costos de apoyo hacia los centros asistenciales. El resultado busca aproximar el costo integral del servicio y apoyar decisiones de eficiencia, presupuesto, tarifa y negociación.

Costos directos

Recursos identificables con un centro o servicio: personal exclusivo, medicamentos, insumos y contratos específicos.

Costos indirectos

Recursos compartidos que requieren inductores: administración, mantenimiento, vigilancia, aseo, sistemas y servicios públicos.

Distribución primaria

Asignación inicial de costos indirectos mediante inductores medibles.

Distribución secundaria

Traslado de costos administrativos y de apoyo a centros productivos.

Costo estimado

Estructura técnica esperada según recursos requeridos por servicio.

Costo real

Ajuste con costos ejecutados, producción y distribución final.

PRINCIPIOS TÉCNICOS

Causalidad, objetividad, consistencia, trazabilidad y razonabilidad. La metodología exige que cada inductor represente el consumo real y que los costos puedan seguirse desde su origen hasta su asignación final.

20. Costos reportados del CAIMI

El costo total reportado para 2025 asciende a $9.828 millones aproximadamente, según la nueva base de centros de costo. Los datos de 2023 y 2026 corresponden a cortes parciales y no deben compararse como vigencias completas. La serie permite identificar magnitud y presión presupuestal, pero no define por sí sola rentabilidad, recaudo efectivo o flujo de caja del centro.

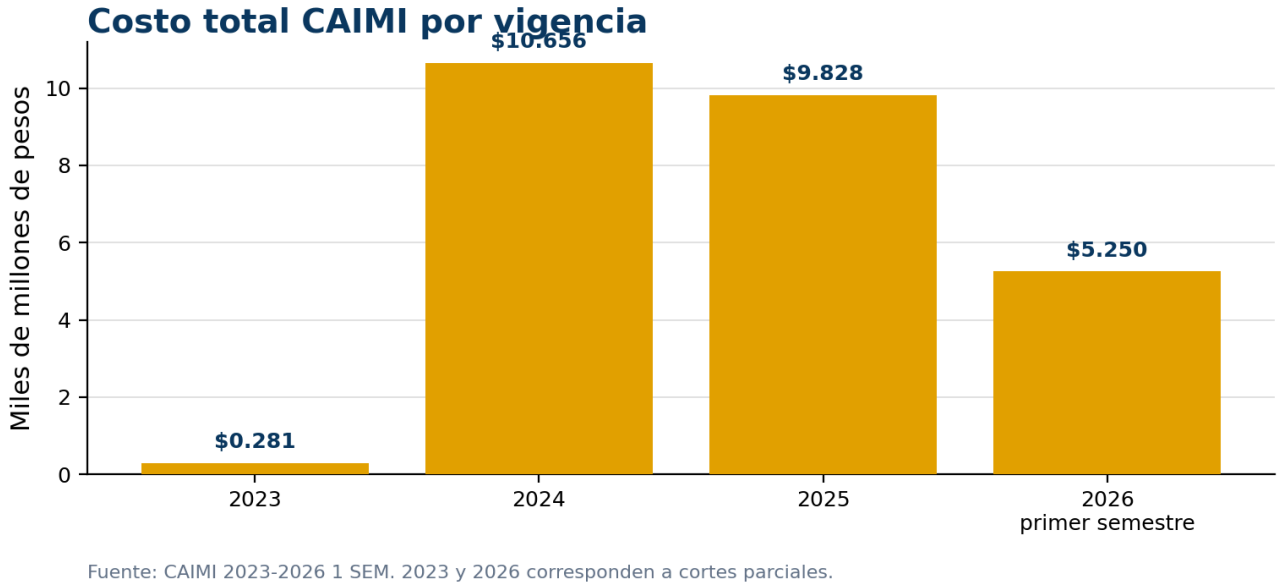


Figura 11. Costo total CAIMI por vigencia

Fuente: CAIMI 2023-2026 1 SEM. Valores en miles de millones de pesos. 2023 y 2026 corresponden a cortes parciales.

Vigencia	Costo total	Nota de interpretación
2023	$280.816.103,82	Corte parcial
2024	$10.656.217.666,73	Vigencia completa
2025	$9.828.115.932,47	Vigencia completa
2026 - primer semestre	$5.250.296.535,41	Primer semestre observado

21. Centros de costo y conciliación

Laboratorio clínico y urgencias concentran cerca del 90% del costo reportado de 2025. Se conservan los totales oficiales por vigencia. Persiste una diferencia de $246.421.769,62 entre componentes y total en una fila de la base de costos, identificada en el anexo 13_Costos_por_centro, fila 11; requiere aclaración de la oficina de costos.

Centro de costo	Tipo	Costo total 2025
LABORATORIO CLÍNICO CAIMI	Operativo	$5.415.542.617,66
URGENCIAS CAIMI	Operativo	$3.425.162.905,11
CONSULTA EXTERNA CAIMI	Operativo	$509.343.909,21
IMAGENOLOGÍA CAIMI	Operativo	$367.403.146,93
HOSPITALIZACION CAIMI	Operativo	$54.789.328,71
SALA DE PARTOS CAIMI	Operativo	$46.670.329,21
P Y P CAIMI	Operativo	$6.799.895,64
SALA DE CIRUGIA CAIMI	Operativo	$2.403.800,00

CONCILIACIÓN Y ALCANCE
Primer semestre de 2026: facturación $4.730.202.897,00; costo $5.250.296.535,41; diferencia -$520.093.638,41. Se corrige la suma derivada que omitía el centro VIEP33. Esta diferencia no es utilidad neta ni flujo de caja. Se conserva la discrepancia entre componentes de $246.421.769,62 para aclaración institucional.

22. Facturación, RIPS, glosas y recaudo

La sostenibilidad financiera depende de que la atención registrada se convierta en factura válida, radicada oportunamente, aceptada y recaudada. La gestión RIPS/FEV debe asegurar consistencia entre paciente, servicio, diagnóstico, CUPS, contrato, tarifa, soporte clínico y responsable de pago.

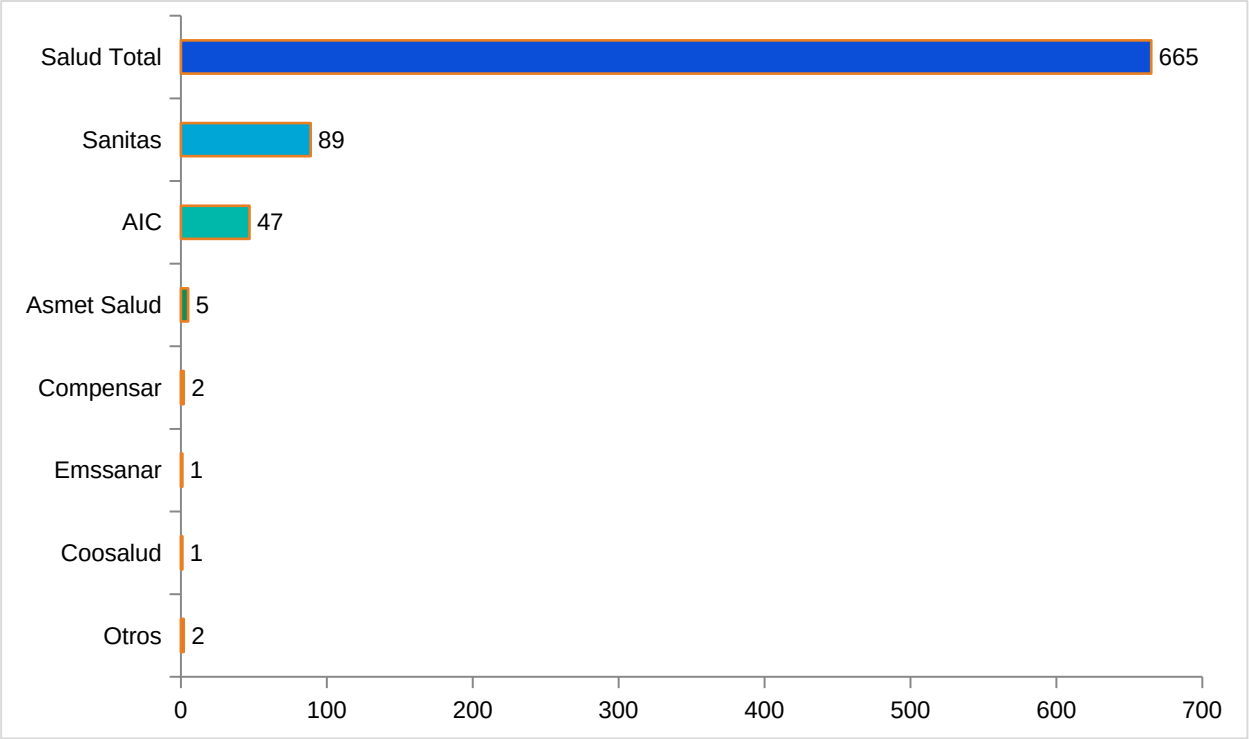


Figura 12. Registros de glosa por EPS

Fuente: GLOSAS-1, P2:P813 (VALOR GLOSA) y H2:H813 (fecha de factura); 812 registros.

Salud Total reúne 665 de los 812 registros (81,9%). La suma de VALOR GLOSA es $58.063.190, con facturas del 21/12/2023 al 23/02/2026. Es un monto multianual pendiente de conciliación por factura; no permite calcular la tasa anual de glosa.

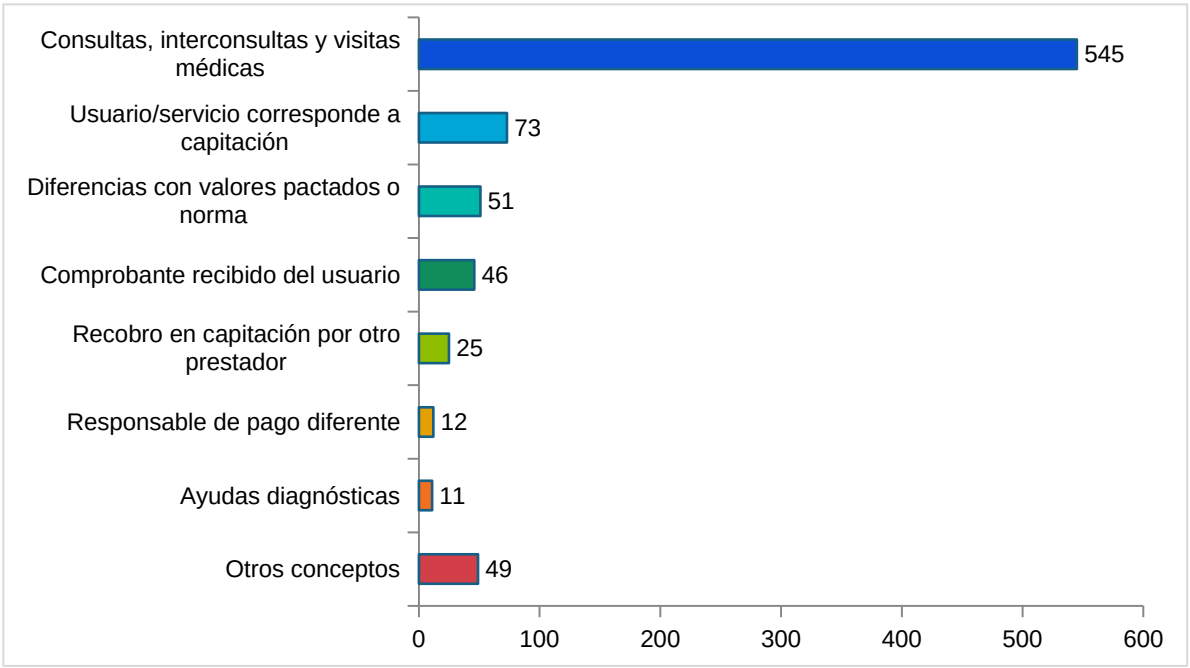


Figura 13. Conceptos recurrentes de glosa

Fuente: *Base institucional de glosas. Los conceptos suman 812 registros.*

Control	Acción	Responsable	Indicador
RIPS/FEV	Validación previa antes de radicación	Facturación / Sistemas	% RIPS aceptados
Soportes	Checklist por contrato y servicio	Auditoría médica	% facturas sin devolución
Tarifas	Conciliación de CUPS, valores y modalidad	Contratación / Facturación	% diferencias corregidas
Glosas	Análisis Pareto, respuesta y cierre	Auditoría / Cartera	Tasa y recuperación de glosa
Recaudo	Cruce factura-pago-cartera	Tesorería / Cartera	Recaudo efectivo

23. Lectura de sostenibilidad

La facturación menos el costo reportado del CAIMI es -$292.650.048,47 en 2025 y -$520.093.638,41 en enero-junio de 2026. Estas diferencias no permiten atribuir utilidad neta ni caja disponible. La conciliación mensual debe integrar radicación, glosas monetarias, recaudo y cartera. Los 812 registros de glosa y su monto multianual no conforman una base anual conciliada.

El modelo financiero del anexo utiliza 2025 como base anual: 33.630 pacientes reportados, facturación de $9.535.465.884 y costo de $9.828.115.932,47. Demanda del 3%, inflación de costos del 6% y recaudo meta del 92% son supuestos editables. La facturación se simula con tarifa y mezcla constantes. No se calcula un flujo de caja validado ni rentabilidad de inversión sin recaudo observado, glosa monetaria y CAPEX sustentados.

Riesgo de sobreestimación

Usar facturación como equivalente de recaudo o asumir que todos los costos por centro son excluyentes.

Riesgo de subestimación

Ignorar valor territorial, demanda, continuidad y costos trasladados a otros nodos.

Decisión responsable

Separar datos observados, cálculos derivados, supuestos y escenarios.

Condición de implementación

Base mensual conciliada y tablero de desempeño antes de contratar o rediseñar.

V

Escenarios y recomendación estratégica

Qué alternativa ofrece el mejor equilibrio y bajo qué salvaguardas.

INFORME FINAL · CONSULTORÍA CAIMI

24. Metodología de evaluación de escenarios

Se conservan las calificaciones originales de ocho criterios, en escala de 1 a 5 y con mayor valor como mejor desempeño. La revisión no identificó pesos documentados que reprodujeran los puntajes anteriores. Se aplica una ponderación uniforme de 12,5% por criterio como supuesto técnico explícito de comparación, sujeto a validación institucional. En riesgo de implementación, una mayor nota representa menor riesgo o mejor control.

Criterio	Pregunta de evaluación
Sanitario	¿Protege resultados, seguridad y gestión del riesgo?
Acceso	¿Mantiene oportunidad y reduce barreras territoriales?
Calidad	¿Sostiene continuidad, soporte diagnóstico y seguimiento?
Financiero	¿Mejora sostenibilidad y control del costo sin depender de supuestos débiles?
Operativo	¿Es implementable con capacidad, procesos, talento y tecnología?
Jurídico	¿Permite una estructura clara, exigible y supervisable?
Riesgo de implementación	¿Qué probabilidad existe de pérdida de control, transición fallida o deterioro?
Territorial	¿Qué efecto tiene sobre la red y la población usuaria?

25. Escenario 1. Continuidad optimizada

DEFINICIÓN

Mantener la operación directa bajo control institucional, transformándola en un plan de eficiencia con metas obligatorias, tablero mensual, costo unitario, control de glosas, gestión de equipos, productividad por perfil y gobierno de datos.

Ventajas	Riesgos	Requisitos
Conserva control público, conocimiento institucional y continuidad directa.	Capacidad gerencial insuficiente para sostener metas y cierres mensuales.	Tablero de KPI, responsables, metas, plan biomédico y conciliación de datos.
Evita costos de transición contractual y dependencia de un operador.	Persistencia de glosas, ineficiencias y fragmentación de información.	Disciplina de ejecución, auditoría concurrente y seguimiento de gerencia.

RESULTADO

Puntaje 3,89/5. Continuidad obtiene la mayor puntuación bajo pesos uniformes, con ventaja mínima. Exige metas, seguimiento y capacidad institucional.

26. Escenario 2. Tercerización condicionada

DEFINICIÓN

Estructurar un contrato por desempeño que preserve acceso, calidad, seguridad, información y control público. No se trata de una cesión simple de la operación, sino de un modelo con obligaciones medibles, riesgos asignados, supervisión y reversibilidad.

Salvaguarda	Exigencia mínima
Acceso y continuidad	Niveles de servicio, horarios, capacidad y rutas sin deterioro.
Calidad y seguridad	Indicadores clínicos, eventos, oportunidad y protocolos.
RIPS, facturación y glosas	Datos completos, validación previa, soporte y responsabilidad explícita.
Información	Propiedad, disponibilidad, respaldo, interoperabilidad y auditoría de la E.S.E.
Activos	Inventario, mantenimiento, reposición, custodia y restitución.
Talento humano	Perfiles, cobertura, continuidad y cumplimiento laboral.
Supervisión	Tablero, auditoría, reuniones, evidencias y consecuencias.
Reversibilidad	Plan de salida y recuperación de la operación.

RESULTADO
Puntaje 3,86/5. La tercerización se mantiene como alternativa estratégica condicionada; no es la opción de mayor puntaje bajo pesos uniformes.

27. Escenario 3. Cierre o reconversión funcional

DEFINICIÓN
Cerrar servicios o reconvertir el centro y trasladar demanda a otros nodos. La evaluación distingue un cierre simple -no recomendado- de una reconversión gradual soportada en capacidad de absorción, continuidad y costos de transición.

Riesgo crítico	Pregunta que debe resolverse
Demanda desplazada	¿Cuántos pacientes y actividades debe absorber la red, en qué servicios y tiempos?
Acceso territorial	¿Aumentan distancias, costos de desplazamiento o demoras?
Continuidad de rutas	¿Cómo se preservan urgencias, apoyo diagnóstico y materno-infantil?
Talento humano	¿Qué transición, traslado o terminación se aplicaría?
Activos e infraestructura	¿Qué uso, custodia, depreciación y mantenimiento continuaría?
Costos	¿Qué costos son evitables, no evitables, hundidos y de transición?

RESULTADO
Puntaje 2,50/5. Cierre simple no recomendado. Una reconversión requiere capacidad de absorción, continuidad asistencial y costos de transición sustentados.

28. Comparación multicriterio y sensibilidad

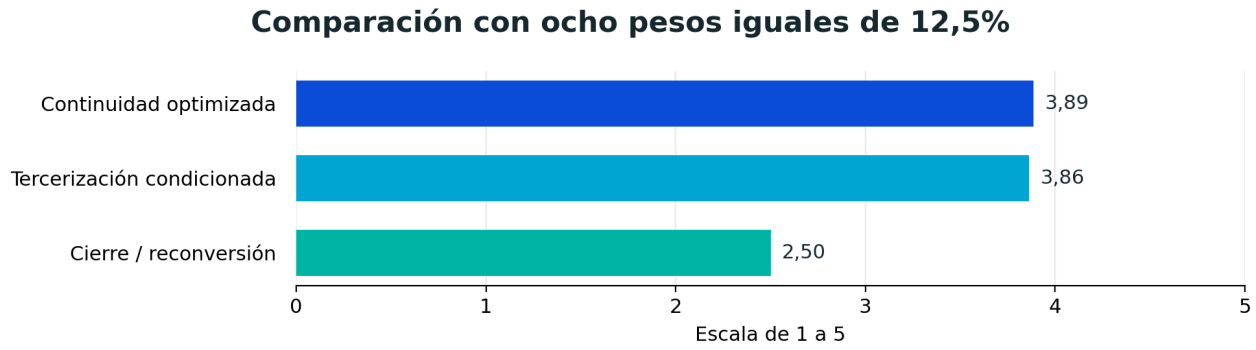


Figura 14. Perfil multicriterio de los escenarios

Fuente: matriz original de ocho criterios y ponderación uniforme de 12,5%; ver anexo E. La nota de riesgo aumenta cuando mejora su control. La clasificación no acredita viabilidad contractual por sí sola.

Escenario	Sanitario	Acceso	Calidad	Financ.	Operativo	Jurídico	Riesgo impl.	Territorial	Puntaje
Continuidad optimizada	4,20	4,50	3,70	2,70	3,20	4,00	4,50	4,30	3,8875
Tercerización condicionada	4,00	4,20	4,10	3,80	4,10	3,50	3,20	4,00	3,8625
Cierre / reconversión	2,20	2,00	2,80	3,40	2,80	2,60	2,30	1,90	2,5000
Peso uniforme	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%

Con pesos uniformes, continuidad optimizada obtiene 3,8875 y tercerización condicionada 3,8625; la diferencia es 0,025 sobre 5. El orden es sensible a las ponderaciones y no fundamenta una superioridad concluyente. Se conserva la tercerización como recomendación estratégica condicionada previa, cuya adopción requiere justificar los pesos y demostrar salvaguardas, viabilidad económica y capacidad de supervisión. Continuidad optimizada es una alternativa técnicamente vigente.

29. Recomendación estratégica

RECOMENDACIÓN TÉCNICA CONDICIONADA
La tercerización permanece como alternativa de estructuración del estudio previo, con dominio público de la información, activos, auditoría y reversibilidad. Su adopción debe justificarse frente a continuidad optimizada, que lidera ligeramente la comparación uniforme. Antes de decidir, validar ponderaciones, conciliación financiera, niveles de servicio y capacidad de supervisión. No se recomienda el cierre simple.

Condiciones mínimas para adoptar la decisión

Condición	Justificación	Evidencia requerida
Conciliación costo-facturación-recaudo-glosa	Evita decisiones con márgenes no atribuibles	Base mensual conciliada
Indicadores de acceso, calidad y continuidad	Protege valor público y rutas	Tablero de KPI con línea base
Auditoría RIPS/FEV	Reduce glosas y devoluciones	Certificados de validación
Plan biomédico	Reduce riesgo asistencial	Semáforo y cierre de hallazgos
Reversibilidad	Evita pérdida de gobernabilidad	Cláusulas y plan de transición
Comité de seguimiento	Asegura control técnico y financiero	Actas mensuales y alertas

VI

Implementación, seguimiento y cierre

Cómo convertir la recomendación en una decisión controlada y medible.

INFORME FINAL · CONSULTORÍA CAIMI

30. Hoja de ruta de implementación

La hoja de ruta se cuenta desde la adopción institucional del plan, no desde una fecha de prórroga contractual presunta. Comienza con conciliación de información, seguimiento biomédico y validación de condiciones de decisión. Deben establecerse responsables, indicadores, supervisión y tratamiento de activos e información antes de implementar el modelo.

Horizonte	Acción prioritaria	Responsable	Producto verificable	Indicador
0-30 días	Conciliar producción, costos, facturación, recaudo y glosas	Subgerencia / Costos / Facturación	Base CAIMI conciliada	% conciliación
0-30 días	Cerrar hallazgos técnicos, corroborar identidades y obtener soporte de placa 8631	Biomédica / Coordinación CAIMI	Plan biomédico y matriz por equipo con evidencia de cierre	% cierre hallazgos
31-100 días	Implementar tablero mensual de gestión CAIMI	Planeación / Sistemas	Dashboard operativo	Actualización mensual
31-100 días	Validar ponderaciones y justificar el modelo seleccionado frente a las alternativas	Gerencia / Jurídica / Subgerencia	Nota técnica y matriz de riesgos	Acto interno de decisión
4-12 meses	Ejecutar modelo seleccionado con indicadores de desempeño	Gerencia / Supervisor	Actas de seguimiento	Cumplimiento KPI
13-24 meses	Evaluar impacto, continuidad y reversibilidad	Comité técnico	Informe anual de evaluación	Puntaje de desempeño

Hitos de control

- Día 30: base CAIMI conciliada, semáforo biomédico y decisión de estructuración.
- Día 100: tablero mensual, nota técnica, matriz de riesgos y alternativa contractual/operativa definida.
- Mes 12: modelo seleccionado ejecutado con evaluación de KPI y acciones correctivas.
- Mes 24: evaluación de impacto, continuidad, sostenibilidad y reversibilidad.

31. Sistema de indicadores

Cada indicador debe disponer de fórmula, fuente, periodicidad, responsable, línea base y evidencia de cierre. Las metas son propuestas para validación institucional. La disponibilidad tecnológica superior al 95% no es un resultado observado del inventario; requiere un registro temporal de equipos críticos.

Código	Indicador	Fórmula	Fuente	Periodicidad	Meta
PROD-01	Producción mensual	Actividades registradas del mes	RIPS / facturación	Mensual	Tendencia controlada, sin caídas no explicadas
GLO-01	Tasa de glosa	Valor glosado / valor facturado	Glosas / facturación	Mensual	< 3%
COST-01	Costo por actividad	Costo total / actividades	Costos / RIPS	Mensual	Reducción progresiva con calidad sostenida
BIO-01	Disponibilidad tecnológica	Horas disponibles / horas requeridas de equipos definidos como críticos	Registro de disponibilidad y mantenimiento	Trimestral	> 95% propuesto; sin medición observada
TH-01	Ausentismo operativo	Días de ausencia / días programados	Talento humano	Mensual	< 3%
RIAS-01	Cumplimiento de ruta	Atenciones RIAS cumplidas / programadas	RIPS / HC	Mensual	> 90%
RIPS-01	RIPS validado	RIPS aceptados / RIPS generados	Sistemas / facturación	Mensual	> 98%

Código	Indicador	Fórmula	Fuente	Periodicidad	Meta
REC-01	Recaudo efectivo	Recaudo / facturación radicada	Cartera / tesorería	Mensual	Meta institucional definida

REGLA DE SEGUIMIENTO

Los indicadores deben revisarse mensualmente por un comité técnico. Las desviaciones requieren causa, responsable, acción, fecha de cierre y validación de efectividad.

32. Matriz integral de riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación prioritaria	Responsable
Datos incompletos	Decisión imprecisa	Gobierno de datos y conciliación mensual	Subgerencia / Planeación
Glosas recurrentes	Pérdida financiera	Auditoría concurrente y checklist de soportes	Facturación / Auditoría
Equipos críticos	Riesgo asistencial	Plan biomédico por criticidad	Biomédica
Tercerización débil	Pérdida de control público	Supervisión, KPI, información y reversibilidad	Gerencia / Jurídica
Cierre sin red	Barreras de acceso	Plan de absorción y continuidad asistencial	Gerencia / Red
Talento sin tablero	Baja productividad	Agenda, perfil, costo y producción	Coordinación CAIMI
RIPS/FEV inconsistente	Rechazo de factura	Validación previa y gobierno de datos	Sistemas / Facturación

33. Conclusiones

01 El CAIMI conserva valor público sanitario y territorial por su papel en servicios de alta demanda, apoyo diagnóstico, urgencias y continuidad de atención.

02 La operación concentra su producción en medicamentos, laboratorio clínico y urgencias; estos frentes deben liderar el control de productividad, insumos, soporte y oportunidad.

03 La producción, pacientes y RIPS corresponden a universos diferentes. La actualización distingue actividades, registros diagnósticos, usuarios deduplicados y pacientes reportados por periodos; mantiene pendientes las conciliaciones que requieren fuente individual.

04 A junio de 2026 la E.S.E. presenta resultado del periodo positivo de $1.103,12 millones y resultado operacional negativo de $1.554,52 millones. Son cifras institucionales y semestrales, no resultados exclusivos del CAIMI.

05 La metodología de costeo por absorción es adecuada para aproximar el costo integral, siempre que inductores, distribuciones y conciliación sean trazables.

06 Las glosas muestran una concentración por EPS y concepto que permite diseñar acciones preventivas focalizadas y medibles.

07 El inventario contiene 194 registros y 15 casos iniciales de no ubicación. La certificación sustenta 12 enlaces por clave, dos asociaciones descriptivas y deja sin reporte individual la placa 8631. Permanecen hallazgos técnicos y de identificación; no se acredita operatividad total.

08 Con pesos uniformes de 12,5%, continuidad obtiene 3,89 y tercerización 3,86. La tercerización se conserva como alternativa estratégica condicionada, sin atribuirle superioridad matemática ni aprobación institucional.

09 La continuidad optimizada requiere metas y capacidad gerencial. La adopción de cualquier modelo exige validar ponderaciones, costos, acceso, supervisión y reversibilidad.

10 La actualización documental incorpora la certificación y sus salvedades. El recibo a satisfacción y el cierre contractual requieren verificación institucional. El cierre asistencial simple no se recomienda sin continuidad de rutas y absorción de demanda.

34. Referencias

- E.S.E. Carmen Emilia Ospina. (2026a). Contrato de consultoría No. 0481 de 2026 y documentos precontractuales.
- E.S.E. Carmen Emilia Ospina. Estados financieros certificados de 2024, 2025 y a 30 de junio de 2026. Fuente institucional, COP.
- E.S.E. Carmen Emilia Ospina. (2026c). Metodología de costeo institucional por absorción.
- E.S.E. Carmen Emilia Ospina. Inventario de equipos biomédicos sede CAIMI, 194 registros. Reyes Moreno, K. C. (23/10/2026). Certificación de equipos biomédicos no ubicados inicialmente y posteriormente identificados, con 14 reportes de servicio anexos, pp. 1-16.
- E.S.E. Carmen Emilia Ospina. Bases de producción y pacientes ITEN 3; CAIMI 2023-2026 primer semestre; GLOSAS 1; RIPS asistenciales y CIE10. Aplicativo previo: rips-v22-data.js, corte 30/06/2026. Cada universo conserva unidad y reglas de agregación propias.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 5185 de 2013.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Resolución 3280 de 2018.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Nota técnica del Decreto 441 de 2022: Lineamientos sobre su construcción, uso y seguimiento.
- Ministerio de Salud y Protección Social. Resoluciones 1440 de 2024 y 2053 de 2025. Modificaciones a la Resolución 5185 de 2013. Texto consolidado oficial: https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_5185_2013.htm (consulta 27/10/2026).
- Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud. Circular Conjunta 007 del 03/03/2025. Prohibición de barreras y requisitos no normados. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-conjunta-007-de-2025.pdf (consulta 27/10/2026).
- Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 0948 del 14/05/2026. RIPS como soporte de FEV en salud. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0948-de-2026.pdf (consulta 27/10/2026).
- Presidencia de la República de Colombia. (2022). Decreto 441 de 2022.

A

Anexos técnicos

Matrices, tablas ampliadas y soportes de trazabilidad.

INFORME FINAL · CONSULTORÍA CAIMI

Anexo A. Producción mensual por servicio

Grupo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Apoyo Diagnostico Imageneologia	4.559	4.837	5.595	5.424	6.059	5.333	4.304	2.922	3.009	3.513	3.171	3.288
Hospitalizacion Estancia General	475	462	614	514	566	386	328	255	216	184	212	244
Laboratorio Clinico	14.001	12.826	14.692	15.301	14.992	14.333	8.738	7.328	6.856	8.159	7.506	8.024
Medicamentos	36.923	33.227	38.148	35.609	39.991	35.673	23.417	18.677	33.000	26.927	21.119	25.769
Observacion	423	346	378	316	333	340	254	222	279	230	207	299
Promocion Y Prevencion	1.052	1.088	1.158	1.196	1.293	906	57	64	44	705	1.262	952
Servicio Ambulatorio - Consulta Externa	2.867	3.059	2.650	2.954	3.226	2.573	2.185	1.952	2.092	2.357	2.252	2.640
Urgencias	12.161	11.712	13.321	12.879	14.733	12.705	9.554	6.935	7.453	7.089	6.722	8.327

Fuente: ITEN 3, hoja Tabla, rangos A10:N21. Ocho grupos seleccionados suman 725.508; ambulancia (4.698) y otros agrupados (95) completan 730.301. Los meses agregan los periodos disponibles y no constituyen una serie de un solo año.

Anexo B. Pacientes, sexo y edad

Periodo	Pacientes
2023 (nov-dic)	13.131
2024	39.624
2025	33.630
2026 (ene-jun)	11.198

Fuente: ITEN 3. Suma por periodos: 97.583 pacientes reportados; no deduplicados entre años. Las dos tablas siguientes usan un universo distinto: 371.987 registros RIPS de diagnóstico principal o egreso.

Sexo en RIPS	Registros	Participación
Femenino	229.407	61,67%
Masculino	142.480	38,30%
Sin dato	100	0,03%

Edad agrupada en RIPS	Registros	Participación
Menores de 6 años	33.502	9,01%
6-11 años	29.521	7,94%
12-17 años	26.387	7,09%
18-28 años	71.348	19,18%
29-59 años	125.557	33,75%
60 años y más	85.572	23,00%
Sin dato	100	0,03%

Fuente: RIPS del aplicativo, corte 30/06/2026. La base contiene 68.318 usuarios únicos globales. Edad agrupada: menores de 6 = <1 y 1-5; 29-59 = 29-44 y 45-59. Usuarios por edad pueden superponerse entre periodos.

Anexo C. Diagnósticos y control de universos

Condición fuente principal / egreso	Registros
DIAGNOSTICO NO VALIDO	71.450
GASTROINTESTINAL	59.223
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	51.206
OTORRINOLARINGOLOGIA	26.566
TRAUMATISMO	25.977
NEUMOLOGICO	24.485
URINARIO	23.777

Condición fuente principal / egreso	Registros
CARDIOVASCULAR	23.066
MATERNO PERINATAL	14.809
ORTOPEDIA	14.041
Otras condiciones	37.387
Total principal / egreso	371.987

Universo / control	Resultado
Diagnósticos RIPS, todos	745.006 registros
Diagnósticos principal / egreso	371.987 registros
Usuarios RIPS deduplicados en la base	68.318 usuarios
Pacientes reportados por periodos	97.583; no deduplicados entre años
Actividades de producción	730.301 en pivote mensual
Aseguradores	Distribución por EPS pendiente de conciliación con fuente individual; no se infiere de glosas

Anexo D. Costos por centro

Centro de costo	Tipo	Costo total 2025
LABORATORIO CLÍNICO CAIMI	Operativo	$5.415.542.617,66
URGENCIAS CAIMI	Operativo	$3.425.162.905,11
CONSULTA EXTERNA CAIMI	Operativo	$509.343.909,21
IMAGENOLOGÍA CAIMI	Operativo	$367.403.146,93
HOSPITALIZACION CAIMI	Operativo	$54.789.328,71
SALA DE PARTOS CAIMI	Operativo	$46.670.329,21
P Y P CAIMI	Operativo	$6.799.895,64
SALA DE CIRUGIA CAIMI	Operativo	$2.403.800,00

Fuente: CAIMI 2023-2026 1 SEM. Valores de la tabla en COP, vigencia completa de 2025; las cifras parciales de otras vigencias no se anualizan.

Anexo E. Matriz multicriterio de escenarios

Escenario	Sanitario	Acceso	Calidad	Financ.	Operativo	Jurídico	Riesgo impl.	Territorial	Puntaje
Continuidad optimizada	4,20	4,50	3,70	2,70	3,20	4,00	4,50	4,30	3,8875
Tercerización condicionada	4,00	4,20	4,10	3,80	4,10	3,50	3,20	4,00	3,8625
Cierre / reconversión	2,20	2,00	2,80	3,40	2,80	2,60	2,30	1,90	2,5000
Peso uniforme	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%

Fuente: calificaciones originales, escala de 1 a 5; ocho pesos de 12,5% como supuesto técnico visible. Puntaje = suma de calificación × peso. La diferencia continuidad-tercerización es 0,025 puntos.

Anexo F. Diccionario de indicadores

Código	Indicador	Fórmula	Fuente	Periodicidad	Meta
PROD-01	Producción mensual	Actividades registradas del mes	RIPS / facturación	Mensual	Tendencia controlada, sin caídas no explicadas
GLO-01	Tasa de glosa	Valor glosado / valor facturado	Glosas / facturación	Mensual	< 3%
COST-01	Costo por actividad	Costo total / actividades	Costos / RIPS	Mensual	Reducción progresiva con calidad sostenida
BIO-01	Disponibilidad tecnológica	Horas disponibles / horas requeridas de equipos definidos como críticos	Registro de disponibilidad y mantenimiento	Trimestral	> 95% propuesto; sin medición observada
TH-01	Ausentismo operativo	Días de ausencia / días programados	Talento humano	Mensual	< 3%
RIAS-01	Cumplimiento de ruta	Atenciones RIAS cumplidas / programadas	RIPS / HC	Mensual	> 90%
RIPS-01	RIPS validado	RIPS aceptados / RIPS generados	Sistemas / facturación	Mensual	> 98%
REC-01	Recaudo efectivo	Recaudo / facturación radicada	Cartera / tesorería	Mensual	Meta institucional definida

Anexo G. Hoja de ruta ampliada

Horizonte	Acción	Responsable	Producto	Indicador
0-30 días	Conciliar producción, costos, facturación, recaudo y glosas	Subgerencia / Costos / Facturación	Base CAIMI conciliada	% conciliación
0-30 días	Cerrar hallazgos técnicos, corroborar identidades y obtener soporte de placa 8631	Biomédica / Coordinación CAIMI	Plan biomédico y matriz por equipo con evidencia de cierre	% cierre hallazgos
31-100 días	Implementar tablero mensual de gestión CAIMI	Planeación / Sistemas	Dashboard operativo	Actualización mensual
31-100 días	Validar ponderaciones y justificar el modelo seleccionado frente a las alternativas	Gerencia / Jurídica / Subgerencia	Nota técnica y matriz de riesgos	Acto interno de decisión
4-12 meses	Ejecutar modelo seleccionado con indicadores de desempeño	Gerencia / Supervisor	Actas de seguimiento	Cumplimiento KPI
13-24 meses	Evaluar impacto, continuidad y reversibilidad	Comité técnico	Informe anual de evaluación	Puntaje de desempeño

Anexo H. Glosas por EPS y concepto

EPS	Registros	Participación
Salud Total	665	81,9%
Sanitas	89	11,0%
AIC	47	5,8%
Asmet Salud	5	0,6%
Compensar	2	0,2%
Emssanar	1	0,1%
Coosalud	1	0,1%
Otros	2	0,2%

Concepto	Registros	Participación
Consultas, interconsultas y visitas médicas	545	67,1%
Usuario/servicio corresponde a capitación	73	9,0%
Diferencias con valores pactados o norma	51	6,3%
Comprobante recibido del usuario	46	5,7%
Recobro en capitación por otro prestador	25	3,1%
Responsable de pago diferente	12	1,5%
Ayudas diagnósticas	11	1,4%
Otros conceptos	49	6,0%

Anexo I. Conciliación biomédica y seguimiento

Clasificación documental consolidada	Registros
Operativo explícito sin incidencia pendiente consignada	106
Operativo con observaciones	66
Fuera de servicio explícito	5
Condición técnica por verificar	12
Intervención en proceso	1
Asociación descriptiva por corroborar	2
Sin reporte individual en certificación	1
Traslado a otra sede registrado	1
Total de registros fuente	194

ALCANCE DE LA CONCILIACIÓN

Las categorías son excluyentes y suman 194 filas fuente. Se mantienen separados los estados, la ubicación y las acciones de gestión. La serie 503352 se repite en los ítems 85 y 88; se requiere conciliación patrimonial sin deduplicar ni sumar activos. Los dos enlaces descriptivos no se cuentan como identidades confirmadas.

Conciliación individual de los 15 casos iniciales

S1: certificación del 23/10/2026 y reportes; las páginas corresponden a su PDF original. S2: inventario fuente. El detalle de 194 registros, transcripción, identidad, ubicación y acciones está en los anexos Excel.

Ítem y clave	Reporte y fecha	Resultado documental y acción
41 · 3404 Succionador	43824 · 2026-10-08 S1 p. 3	Funciona con observaciones; fisura en reservorio; recomienda cambiar reservorio Gestionar cambio de reservorio y corroborar serie
101 · 2820 Micropipeta	43823 · 2026-10-08 S1 p. 4	Fuera de servicio; no pasa test de volumen, deterioro de carcasa y sistema de lectura bloqueado; recomienda baja Evaluación institucional de recomendación de baja y validación del rango
140 · 3237 Equipo De Órganos De Pared	42295 · 2026-07-09 S1 p. 5	Fuera de servicio; faltan dos cabezales Gestionar cabezales y nueva validación funcional
141 · 6397 Tensiómetro De Pared	42296 · 2026-07-09 S1 p. 6	Equipo operativo en el servicio Actualizar ubicación en registro institucional
153 · 3259 Succionador	43825 · 2026-10-08 S1 p. 7	Servicio en proceso; requiere niple de 1/4 para fijar manguera siliconada Completar intervención, registrar resultado y ubicación
170 · 4427 Pesa Bebé	40998 · 2026-08-03 S1 p. 8	Fuera de servicio; daño en celda de pesaje, ajuste/calibración intentados sin éxito; recomienda baja Evaluación institucional de recomendación de baja
172 · 6222 Doppler Fetal	42229 · 2026-07-14 S1 p. 9	Equipo funciona correctamente Actualizar ubicación y trazabilidad
175 · 3225 Lampara Cuello Cisne	42232 · 2026-07-14 S1 p. 10	Equipo operativo en el servicio Actualizar ubicación y trazabilidad
176 · 3223 Lampara Cuello Cisne	42233 · 2026-07-14 S1 p. 11	Equipo operativo en el servicio Actualizar ubicación y trazabilidad
177 · 8631 Bascula De Piso	Sin reporte individual S1 pp. 1-16	No se identifica soporte individual en esta certificación. Obtener reporte o verificación individual de placa 8631 / serie 25689-334
179 · serie 180309105049 Tensiometro Pediatrico	42236 · 2026-07-14 S1 p. 12	Equipo operativo en el servicio Actualizar ubicación y trazabilidad
180 · serie 18030188 Fotoforo Luz Fria	42237 · 2026-07-14 S1 p. 13	Equipo operativo en el servicio Actualizar ubicación y validar transcripción de código/modelo
181 · sin clave individual Fonendoscopio	42238 · 2026-07-14 S1 p. 14	Equipo funciona correctamente Corroborar individualización y asignar identificador institucional si corresponde Enlace descriptivo, identidad por corroborar.
182 · sin clave individual Lapiz Halogeno	42239 · 2026-07-14 S1 p. 15	Funciona con observaciones; requiere baterías, dos pilas AAA Corroborar individualización y gestionar baterías Enlace descriptivo, identidad por corroborar.
183 · 5513 Pesa Gramera	42240 · 2026-07-14 S1 p. 16	Equipo operativo en el servicio Actualizar ubicación y trazabilidad

Diferencias de identificación conservadas: la serie del succionador 3404 difiere en un cero; el rango de la micropipeta 2820 y la serie del tensiómetro 6397 requieren lectura conjunta de fuente y manuscrito. En el fotóforo, la coincidencia se realiza por serie y no por el código de placa ambiguo. Las bajas de 2820 y 4427 son recomendaciones, sin acto de baja aportado.

Reglas de actualización y cierre

Los resúmenes previos de 217 registros, 13 no ubicados y 41 residuales no contaban con correspondencia individual verificable. Se sustituyen por el conteo de 194 filas, 15 observaciones iniciales y una clasificación de cada registro. No se atribuye a la certificación la resolución automática de todos los hallazgos. La gestión posterior debe registrar responsable institucional, soporte, fecha y validación de cierre.

Anexo J. Normograma resumido

Norma	Aplicación	Uso
Ley 100 de 1993, art. 195	Régimen jurídico de las E.S.E.	Marco institucional y contractual
Resolución 5185 de 2013 y modificaciones	Lineamientos del estatuto de contratación de E.S.E.	Planeación contractual
Resoluciones 1440 de 2024 y 2053 de 2025	Modificaciones de los lineamientos; art. 9 actualizado en 2025	Verificar modalidad, objeto y financiación aplicables
Resolución 3280 de 2018	Rutas de promoción y mantenimiento y materno-perinatal	Indicadores y continuidad de rutas
Decreto 441 de 2022	Acuerdos de voluntades y modalidades de pago	Nota técnica, riesgo y seguimiento
Resolución 0948 de 2026	RIPS como soporte de FEV; deroga 2275/2023, 558/2024 y 1884/2024	Validación y gobierno de datos
Circular Conjunta 007 de 2025	MinSalud y Supersalud: barreras, requisitos no normados y pagos	Radicación sin exigencias adicionales no previstas
Marco contable aplicable de la CGN	Reconocimiento, medición y presentación	Lectura de estados financieros institucionales

Una decisión basada en evidencia

Acceso, continuidad, sostenibilidad y control público como criterios de cierre.

INFORME FINAL · CONSULTORÍA CAIMI